הקבלה במרפאת טרום ניתוח

מה כותבים, איפה ואיך · תדרוך לסטאז׳רים ולמתמחים

על קוד של מתמחה
מציינים שהקבלה נכתבה על ידכם, כולל שם הסטאז׳ר/ית.

כל נושא ברובריקה שלו
בקמיליון: תרופות תחת תרופות, ניתוחים תחת ניתוחים.

לא משאירים לאשפוז
התורן בלילה עמוס. סוגרים הכול בטרום, כולל אק״ג.

בדיקה חסרה?
פקס למזכירת המחלקה: **08-9441790**

הסכמה לניתוח
מחתים **מתמחה בלבד**. גישה ניתוחית וצד מדויקים, ובספק בודקים מול המנתח.

בסוף
מדפיסים וחותמים.

1 תלונה עיקרית

הופנה לניתוח _____ בשל _____ (האינדיקציה).

דוגמה: כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית בשל אירועים חוזרים של דלקת.

2 מחלה נוכחית

- פותחים ב: **בן/בת XX, סובל/ת מ...** ומחלות הרקע בכותרות. הפירוט בהמשך.
- הדמיה (CT, MRI): עיקרי הפענוח עם תאריך. רק מה שרלוונטי, בלי העתק־הדבק.
- יש גרורות מרוחקות? **מדברים עם המתמחה.**
- ממצאי הבירור לפי סדר כרונולוגי.
- מי הכירורג שהפנה ומה האינדיקציה.
- **ממאירות:** מה הוחלט בישיבת הגידולים.
- מבקשים סיכום מרופא המשפחה. חוסך זמן בתרופות ובמחלות הרקע.

3 מחלות רקע: מפורט ויסודי

- **בכל קבלה:** עישון ו-BMI.
- **מחלת לב איסכמית:** צנתורים, אילו עורקים, מתי ואילו תרופות. אישור קרדיולוג לסיכון הניתוחי ולהפסקת נוגדי קרישה.
- **פרפור פרוזדורים:** הטיפול הקבוע. **אירוע מוחי:** מתי ומה.
- **סכרת:** מאוזנת או לא, טיפול קבוע, HbA1c ופגיעה באיברי מטרה (עיניים, כליות, נוירופתיה).
- **מחלת ריאות:** סיכום רופא ריאות והתייחסות לסיכון.
- בכל מחלה: יש ייעוץ? מה הוא אומר? חסר ייעוץ? מציינים.
- עוברים על כל התיק ומכניסים את כל הייעוצים.

4 בדיקה גופנית

- מלאה, כולל לב וריאות.
- בדיקה מכוונת לסיבה שבגללה הופנה/תה לניתוח.
- בדיקה רקטלית.

5 בדיקות טרום ניתוח

טבלת הבדיקות הנחוצות בסביסטון ונהלי המחלקה. הכול מ-3 החודשים האחרונים.

אק״ג	מפרטים. אין, או באיכות לא טובה? עושים שוב.
צילום חזה	אין פענוח? מסתכלים וכותבים. **יש CT חזה? לא צריך צילום.** מציינים ברובריקה.
דם	המוגלובין, טסיות, לויקוציטים, קריאטינין, Na, K, INR. לפי הצורך: סמנים, אלבומין, מדדי דלקת. תאריך ברובריקה.
לא עדכני?	מכתב לרופא המשפחה עם הבדיקות. המטופל מגיע איתן ליום הניתוח.

6 ניתוחים בעבר

- מתי, איזה ניתוח ובאיזה חתך (למשל אפנדקטומי לפרוסקופי או מקברני).
- לא ברשימה? כותבים "לטיפול הרשמת" ואת שם הניתוח בהערות.

7 תרופות קבועות

- **דיוק! מוודאים מול המטופל ומול הרשומות.**
- מינון, תדירות ודרך מתן.
- נוגדי קרישה (אספירין, קומדין, פלביקס, קלקסן ודומיהם): מתי הופסקו ולמה ניתנים.
- מסבירים למטופל מה ממשיכים ומה מפסיקים.

והכי חשוב: מפעילים שיקול דעת ושואלים את המתמחה בכל שאלה.

8 מה מוסיפים לפי תחום

בקעים

- לפי מכתב ההפניה: איזה בקע, איזה תיקון ומה האינדיקציה.
- בדיקה: שני הצדדים והטבור. צלקות קודמות. בגברים גם אשכים.
- שואלים על מתן שתן ונוקטוריה.
- בקע בצלקת: אילו ניתוחים ומתי.
- עישון ו-BMI.
- האם עבר קולונוסקופיה ומה הייתה התוצאה.

בריאטריה

- מדד מסת גוף (BMI), מחלות רקע ואינדיקציה. עוברים על כל המפגשים במרפאה הבריאטרית.
- שיקוף בליעה, גסטרוסקופיה ו-TSH.
- בדיקות דם: ויטמינים, פריטין ועוד.
- ניתוח קודם כמו טבעת: לציין את הסוג (LAGB, SRVG).

שד

- מרפאת השד או מכתב ההפניה: אפיון הגידול ואינדיקציה.
- **צד ימין או שמאל: חשוב!**
- כרונולוגיה: פתולוגיה, סמנים, סימון מתוכנן (איזוטופים או תיל).
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי, בדיקה גנטית ושיתוף פלסטיקאים.

קולון

- הערות המנתח.
- בירור סיסטמי: CT, צילום חזה, PET CT לפי הצורך.
- קולונוסקופיה ו-TRUS אם יש. פתולוגיה (כולל MMR), סמנים ו-MRI.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי והשיפור אחריו.

הפטוביליארי

- איזה ניתוח, התייצגות וסיבת הבירור.
- הבירור המקומי והסיסטמי לפי תאריכים. EUS ו-MRI: יחס לכלי דם.
- פתולוגיה ומרקרים. ניקוז דרכי מרה או ERCP.
- מעבדה: גם אנזימי כבד ובילירובין.

קיבה

- תוצאות גסטרוסקופיה ופתולוגיה.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי.
- תוצאות הבירור הסיסטמי (CT).

✓ לפני שמדפיסים

- ☐ תלונה עיקרית: ניתוח + אינדיקציה
- ☐ ממאירות: החלטת ישיבת הגידולים
- ☐ כל מחלות הרקע עם הייעוצים
- ☐ תרופות: מינון, תדירות ודרך
- ☐ נכתב ע״י: שם הסטאז׳ר/ית
- ☐ הודפס ונחתם
- ☐ מי הכירורג שהפנה
- ☐ בדיקה גופנית מלאה, כולל רקטלית
- ☐ אק״ג, צילום חזה (או CT) ודם מ-3 חודשים
- ☐ נוגדי קרישה: מתי הופסקו
- ☐ אין שום דבר שנשאר לאשפוז
- ☐ הבירור לפי תאריכים
- ☐ עישון ו-BMI
- ☐ כל ניתוח ברובריקה שלו, עם חתך
- ☐ הוסבר למטופל מה ממשיכים
- ☐ הסכמה: ע״י מתמחה, גישה וצד מדויקים

בעמודים הבאים · שלוש קבלות לדוגמה

1 **כיס מרה** כריתה בגישה לפרוסקופית

2 **בקע מפשעתי** תיקון בגישה פתוחה, עם נוגדי קרישה

3 **קולון** כריתת מעי גס ימני

קבלות לדוגמה · 1 מתוך 3

כריתת כיס מרה

מקרה 1 · מטופלת בת 50, ניתוח אלקטיבי.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **50**	תאריך: ___/___/____

פרטים	בת 50, אלקטיבית לניתוח כריתת כיס מרה.
רקע רפואי	סכרת סוג 2, מאוזנת (HbA1C 5.5%), בטיפול במטפורמין, ללא פגיעה באיברי מטרה. דיסליפידמיה.
עישון ו-BMI	לא מעשנת. BMI 29.
רגישות לתרופות	פניצילין (פריחה).
תרופות קבועות	• LITROVA • METFORMIN
נוגדי קרישה	ללא טיפול במדללי דם.
רקע ניתוחי	• לידה קיסרית, 2010.
מחלה נוכחית	• אשפוז במחלקה כירורגית ב-08.2026, בתמונה של דלקת כיס מרה. קיבלה טיפול שמרני. שוחררה עם המלצה להשלמת MRCP לפני ניתוח. • אולטרסאונד בטן הדגים: כיס מרה עם אבנים בתוכו, עיבוי דופן, לא הודגמה הרחבה בדרכי מרה. • במעבדה הייתה הפרעה באנזימי כבד: GGT 220 וכן ALKP 150. • בתאריך 15.09.2026 בוצע MRCP: כיס מרה ללא סימני דלקת, עם אבנים בתוכו, דרכי מרה לא מורחבות, לא הודגמו אבנים בדרכי מרה.
הערכה טרום ניתוחית	• צילום חזה 01.10.2026: לא הודגם תפליט, תסנין או גודש. • אק״ג 01.10.2026: קצב סינוס סדיר, ללא ממצא חריג. • מעבדה 01.10.2026: ללא ליקוציטוזיס, המוגלובין 14, טסיות 210 אלף. קריאטינין תקין, אלקטרוליטים בדם תקינים, בילירובין תקין, אנזימי כבד תקינים. המוגלובין מסוכרר HbA1C 5.5%, תפקודי קרישה INR 1.
בדיקה גופנית	• ריאות: כניסת אוויר טובה ושווה דו״צ. • לב: קולות לב סדירים, לא נשמעו אוושות. • בטן: רכה, לא רגישה. צלקת ניתוחית רוחבית בבטן תחתונה. לא נמששו בקעים בדופן הבטן. • בדיקה רקטלית: ללא ממצא חריג. • גפיים: ללא סימני DVT.
הערכת מרדים	יש אישור לניתוח, ללא המלצות מיוחדות.
הסכמה לניתוח	הוחתמה ע״י ד״ר [שם] (מתמחה): כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית.
תכנית	**לניתוח בהצלחה.**

לדוגמה בלבד

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם]

הודפס ונחתם ✓

קבלות לדוגמה · 2 מתוך 3

תיקון בקע מפשעתי ימני

מקרה 2 · מטופל בן 76, ניתוח אלקטיבי בגישה פתוחה, עם רקע לבבי ונוגדי קרישה.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **76**	תאריך: ___/___/____

פרטים	בן 76, אלקטיבי לתיקון בקע מפשעתי מימין בגישה פתוחה.
רקע רפואי	יתר לחץ דם, אי ספיקת לב, מחלת לב איסכמית (עבר 3 צנתורים, האחרון ב-2023), פרפור פרוזדורים, סכרת סוג 2 מאוזנת (HbA1C 6.7%), בטיפול בפורסיגה, ללא פגיעה באיברי מטרה ידועה), תת פעילות של בלוטת התריס, מצב אחרי ממאירות בערמונית.
עישון ו-BMI	עישן בעבר, הפסיק לפני 20 שנה. BMI 27.
רגישות לתרופות	לא ידוע על רגישות לתרופות.
תרופות קבועות	• Losartan • Concor • Fusid • Forxiga
נוגדי קרישה	נוטל אליקוויס (Apixaban).
רקע ניתוחי	• 2010: תיקון בקע מפשעתי משמאל בגישה פתוחה, עם הנחת רשת. • 2022: כריתת ערמונית בגישה פתוחה. • כריתת תוספתן בגישה פתוחה, בגיל 22.
מחלה נוכחית	נבדק במרפאה כירורגית ע״י ד״ר [שם] ב-08.2026. סובל מכאב במפשעה ימין תקופה ארוכה. בבדיקתו: בקע מפשעתי ימני, אינגווינוסקרוטלי, חוזר בקלות. ללא בקע משמאל. הופנה לניתוח תיקון בקע בגישה פתוחה. קולונוסקופיה ב-2024: ללא ממצא חריג.
הערכה טרום ניתוחית	• הערכת קרדיולוג, ד״ר [שם], 05.08.2026: אין מניעה מבחינה לבבית לניתוח תיקון בקע. יש להפסיק את הדילול (אפיקסבן) 48 שעות לפני הניתוח. • צילום חזה 02.08.2026: ללא תסנין, תפליט או גודש. • אק״ג 02.08.2026: קצב סינוס סדיר, RBBB. • מעבדה 02.08.2026: ללא ליקוציטוזיס, המוגלובין 13, טסיות 156 אלף. קריאטינין 0.7, אלקטרוליטים בדם תקינים. תפקודי קרישה INR 1, המוגלובין מסוכרר HbA1C 6.7%. תפקודי בלוטת התריס (TSH, T3, T4) תקינים.
בדיקה גופנית	• ריאות: כניסת אוויר טובה ושווה דו״צ. • לב: קולות לב סדירים. • בטן: רכה, לא רגישה. בקע מפשעתי אינגווינוסקרוטלי מימין, חוזר בבדיקה. לא נמשש בקע משמאל. צלקות ניתוחיות: בבטן תחתונה ימנית (מקברני), בבטן תחתונה שמאלית (תיקון הבקע הקודם) ובבטן תחתונה אמצעית (כריתת הערמונית). • בדיקה רקטלית: ללא ממצא חריג. • גפיים: בצקת +1 דו״צ, ללא סימני DVT.
הערכת מרדים	מאושר.
הסכמה לניתוח	הוחתם ע״י ד״ר [שם] (מתמחה): תיקון בקע מפשעתי **ימני** בגישה פתוחה.
תכנית	**הפסקת אליקוויס 48 שעות לפני הניתוח. לניתוח בהצלחה.**

לדוגמה בלבד

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם]

הודפס ונחתם ✓

קבלות לדוגמה · 3 מתוך 3

כריתת מעי גס ימני

מקרה 3 · מטופל בן 65, ניתוח אלקטיבי, עקב ממצא בתוספתן אחרי כריתתה.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **65**	תאריך: ___/___/____

פרטים	בן 65, אלקטיבי לניתוח כריתת מעי גס ימני, עקב mucinous neoplasm of appendix.
רקע רפואי	יתר לחץ דם.
עישון ו-BMI	מעשן, 20 סיגריות ליום. BMI 31.
רגישות לתרופות	לא ידוע על רגישות לתרופות.
נוגדי קרישה	ללא טיפול במדללי דם.
רקע ניתוחי	• 01.09.2026: כריתת תוספתן בגישה לפרוסקופית.
מחלה נוכחית	• אשפוז במחלקה כירורגית ב-01.09.2026 עקב דלקת תוספתן. עבר כריתת תוספתן בגישה לפרוסקופית, במהלך תקין. • בפתולוגיה: mucinous neoplasm of appendix בבסיס התוספתן, עם מעורבות של שול הכריתה. • נבדק במרפאה כירורגית ע״י ד״ר [שם]. הומלץ על ניתוח כריתת מעי גס ימני, ויש להשלים קולונוסקופיה לקראת הניתוח. • קולונוסקופיה 10.10.2026: הבדיקה בוצעה עד הצקום, מעי גס במראה תקין לכל אורכו. • נדון בישיבת גידולים ב-14.10.2026: הוחלט על כריתת מעי גס ימני.
הערכה טרום ניתוחית	• צילום חזה 01.10.2026: לא הודגם תפליט, תסנין או גודש. • **אק״ג: חסר.** • מעבדה 01.10.2026: ספירה תקינה, INR תקין, אלקטרוליטים בדם וקריאטינין תקינים.
בדיקה גופנית	• ריאות: כניסת אוויר טובה ושווה דו״צ. • לב: קולות לב סדירים. • בטן: רכה, לא רגישה. צלקות לפרוסקופיה מחלימות היטב. • בדיקה רקטלית: ללא ממצא חריג.
הערכת מרדים	**לא מאושר זמנית.** יש להביא אק״ג עדכני ביום הניתוח.
הסכמה לניתוח	הוחתם ע״י ד״ר [שם] (מתמחה): כריתת מעי גס ימני, הגישה אומתה מול המנתח.
תכנית	• **להשלים אק״ג בקופת חולים.** • הכנת מעי לקראת הניתוח.

לדוגמה בלבד

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם]

הודפס ונחתם ✓